

TRẮC NGHIỆM THI DỊCH TỄ HỌC

Phần 1: ĐÚNG/SAI

1 số đv hoang dã (chuột) và vật nuôi (lợn) là khối cảm thụ của bệnh dịch hạch S
1 số loài chim hoang dã là khối cảm thụ của bệnh dịch hạch S
Bệnh bạch hầu lây theo đường tiêu hóa S
Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm từ sinh vật sang người S
Bệnh tăng HA hay tăng HA tiên phát: là tăng HA không rõ nguyên nhân, chiếm tới 90-95% các TH tăng HA Đ
Bệnh vàng da xoắn khuẩn lây truyền theo đường da và niêm mạc Đ
Bọ chét chuột là khối cảm thụ của bệnh dịch hạch S
Bọ chét là nguồn truyền nhiễm của bệnh dịch hạch S
Các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp diễn biến quanh năm và hay gặp những tháng lạnh, ẩm Đ
Các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp diễn biến quanh năm và hay gặp vào những tháng lạnh, ẩm
Các biện pháp phòng chống dịch của nhóm bệnh TN đường hô hấp thì với đường truyền là rất dễ thực hiện S
Các biện pháp phòng chống dịch của nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp thì với đường truyền là rất dễ thực hiện
Các biện pháp phòng chống dịch tổng hợp là tác động và cả 3 khâu của quá trình dịch Đ
Chim, lợn là nguồn truyền nhiễm của viêm não Nhật Bản Đ
Côn trùng tiết túc là nguồn truyền nhiễm S
Điều trị ngăn không cho biến chứng xảy ra là biện pháp dự phòng cấp 3 các bệnh tim mạch Đ
Dự phòng cấp 2 cho bệnh tim mạch là: điều trị sớm khi mà có thể chữa khỏi được Đ
Giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành là biện pháp dự phòng cấp 2 S
Miễn dịch chủ động hình thành sau khi bị nhiễm trùng có triệu chứng hay không có triệu chứng lâm sàng Đ
Miễn dịch nhân tạo chủ động khi đưa các kháng nguyên vào cơ thể để tạo ra kháng thể Đ
Miễn dịch nhân tạo chủ động khi đưa các kháng nguyên vào cơ thể để tạo ra kháng thể
Miễn dịch trong sốt rét là miễn dịch bền vững suốt đời
Miễn dịch trong sốt rét là miễn dịch tự nhiên Đ
Miễn dịch trong sốt trét là miễn dịch tự nhiên
Miễn dịch tự nhiên chủ động hình thành sau khi bị nhiễm trùng có triệu chứng hay không có triệu chứng lâm sàng
Một số loài chim hoang dã là khối cảm thụ của bệnh dịch hạch
Nghiên cứu bệnh chứng có hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm S
Nghiên cứu bệnh chứng có hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm
Nghiên cứu bệnh chứng khó xác định mối quan hệ về mặt thời gian giữa phơi nhiễm và bệnh Đ
Nghiên cứu bệnh chứng khó xác định mối quan hệ về mặt thời gian giữa phơi nhiễm và bệnh
Nghiên cứu biến chứng cho phép tính toán trực tiếp tỷ suất mới mắc bệnh ở cả 2 nhóm phơi nhiễm và ko phơi nhiễm hiếm S
Nghiên cứu biến chứng có hiệu quả khi nghiên cứu các phơi nhiễm hiếm gặp S
Người mang mầm bệnh thương hàn là nguồn lây truyền bệnh
Người mang mầm bệnh thương hàn là nguồn lây truyền bệnh Đ
Phải thông báo quá trình các bệnh: dịch tả, sốt vàng, dịch hạch Đ

Phải thông báo quốc tế các bệnh : dịch tả, sốt vàng , dịch hạch
Phải thông báo quốc tế với các bệnh: dịch tả, sốt vàng, dịch hạch Đ
Phát hiện sớm tăng huyết áp giới hạn ,điều trị kịp thời ,làm cho huyết áp trở về bình thường là biện pháp dự phòng cấp 1
Phát hiện sớm tăng huyết áp giới hạn, điều trị kịp thời, làm cho tăng HA trở về bình thường là biện pháp điều trị dự phòng cấp 1 S
Phụ nữ có thai mắc sốt rét sẽ có khả năng truyền sang thai nhi
Phụ nữ có thai mắc sốt rét về có khả năng truyền sang thai nhi Đ
Phụ nữ được bảo vệ và ít bị bệnh tim mạch hơn nam giới cho đến tuổi mãn kinh Đ
Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá là : Phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân
Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá là : Cắt đường truyền nhiễm
Pp phòng chống có hiệu quả tốt nhất đối với bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa là cắt đường truyền nhiễm Đ
PP phòng chống có hiệu quả nhất với bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa: phát hiện sớm và điều trị bệnh nhân S
Sàng tuyển phát hiện ung thư vú sớm và điều trị là biện pháp dự phòng cấp 2
Tác nhân gây cúm là 5 loại virus sau: A, B, C, D, E S
Tại vùng sốt rét lưu hành có người lành mang ký sinh trùng sốt rét Đ
Tần số (frequency) biểu thị số lần xuất hiện 1 quan sát nào đó. Ví dụ: số người có ký sinh trùng sốt rét trong máu khi kiểm tra lam máu Đ
Tần số biểu thị số lần xuất hiện của 1 quan sát nào đó Đ
Tần số cộng dồn của 1 ô nào đó bằng tần số của chính ô đó cộng với tần số của ô trước đó Đ
Tần số tuyệt đối là tần số thực của 1 ánh sáng, nó phụ thuộc vào cỡ mẫu lớn hay nhỏ S
Tần số tuyệt đối là tần số thực của 1 quan sát, nó phụ thuộc vào cỡ mẫu lớn hay nhỏ S
Trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh: trẻ sinh ra từ bà và mẹ được tiêm 3 mũi vaccin uốn ván trong quá khứ và 2 mũi trong thời kỳ mang thai Đ
Trong bệnh cúm, người bệnh và người lành mang trung là nguồn bệnh duy nhất
Trong bệnh cúm, người bệnh và người lành mang trùng là nguồn bệnh duy nhất Đ
Trong bệnh cúm, người bệnh và người lành mang trùng là nguồn duy nhất Đ
Tử lệ mắc bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá thường tăng cao vào các tháng lạnh, ẩm.
Vaccin cúm tạo được miễn dịch bền vững và chắc chắn S
Vaccin sởi được chế tạo từ virus sởi sống đã làm giảm độc lực Đ
Vị trí cảm nhiễm thứ 2 quyết định con đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ S
Vị trí cảm nhiễm thứ 2 quyết định con đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ S
Vị trí cảm nhiễm thứ hai quyết định con đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ
Yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng nhiều đến yếu tố truyền nhiễm
Yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng nhiều đến yếu tố truyền nhiễm Đ

Phần 2: CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN:

Bài 2: Số đo mắc bệnh và tử vong

<i>Biện pháp nào sau đây không phải biện pháp khống chế phơi nhiễm: Ghép cặp</i>
<i>Có 112 người bị ốm trong đó 76 nữ và 36 nam sau một cuộc dã ngoại trong tổng số 250 người (80 nam và 170 nữ). Tỷ lệ được tính toán đúng là : Tỷ lệ tấn công chung @ $112/250 = 0,45$</i>
<i>Có 112 người bị ốm, trong đó 72 nữ và 36 nam. Sau một cuộc dã ngoại trong tổng số 250 người (80 nam và 170 nữ). Tỷ lệ được tính toán đúng là: Tỷ lệ tấn công chung $112/250 = 0,45$</i>
<i>Có 112 người bị ốm trong đó 76 nữ và 36 nam sau một cuộc dã ngoại trong tổng số 250 người (80 nam và 170 nữ). Tỷ lệ được tính toán đúng là : Tỷ lệ tấn công chung @ $112/250 = 0,45$</i>
<i>Để đánh giá mức độ kết hợp giữa một phơi nhiễm và một bệnh, những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất là : Nguy cơ tương đối của bệnh</i>
<i>Để đánh giá mức độ kết hợp giữa một phơi nhiễm với một bệnh những chỉ số dịch tễ học có lợi ích nhất là: Nguy cơ quy thuộc</i>
<i>Để đánh giá mức độ kết hợp giữa một phơi nhiễm và một bệnh, những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất là : Nguy cơ tương đối của bệnh@</i>
DỊCH TỄ HỌC LÀ B. 1 MÔN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU TÀN XUẤT MẮC HOẶC CHẾT ĐỐI VỚI BỆNH TRẠNG CÙNG VỚI NHỮNG...
<i>Giai đoạn I trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm: Nghiên cứu tính hiệu quả</i>
<i>Giai đoạn II trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm: Thử nghiệm trên phạm vi lớn</i>
<i>Giai đoạn III trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm: Thử nghiệm trên phạm vi nhỏ</i>
<i>Giai đoạn IV trong thử nghiệm thuốc điều trị KHÔNG bao gồm: Đánh giá chi phí hiệu quả sử dụng của thuốc</i>
<i>Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng giảm tỷ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh, sẽ dẫn tới tình huống sau: Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ tăng</i>
<i>Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng làm giảm tỷ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh, sẽ dẫn đến tình huống sau: Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ tăng</i>
<i>Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng làm giảm tỷ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh, sẽ dẫn đến tình huống sau: Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ tăng</i>
<i>Khi một loại thuốc hay một phương pháp điều trị có khả năng làm giảm tỷ lệ chết nhưng không làm khỏi hẳn bệnh, sẽ dẫn đến tình huống sau: Tỷ suất hiện mắc của bệnh sẽ tăng</i>
<i>Kỹ thuật ghép cặp dùng để: Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng đến sự phân bố của bệnh mà người ta nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng</i>
<i>Mẫu số để đo lường tỷ suất mật độ mới mắc một bệnh xảy ra là: Số năm người quan sát được</i>
<i>Mẫu số để đo lường tỷ suất mật độ mới mắc một bệnh xảy ra là: Số năm người quan sát được.</i>
<i>Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết thô (crude mortality rate) ở cộng đồng A là: $10/1.000$ @</i>
<i>Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết do lao là: 6% @</i>
<i>Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết trên mắc (case fatality rate) của lao là: 20% @</i>

Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo nguyên nhân (cause specific mortality rate) đối với lao là: 60/100.000 @
Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Cứ 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo giới (sex specific mortality rate) đối với lao là: không thể tính được từ số liệu đó cho @
Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết thô (crude mortality rate) ở cộng đồng A là: 10/1.000
Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết do lao là: 6%
Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. trong năm 2001, có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó 50 là nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo giới (sex specific mortality rate) đối với lao là:
Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001 có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó có 50 là nam. Tỷ lệ chết thô ở cộng đồng A là: 10/1000
Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001 có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó có 50 là nam. Tỷ lệ chết trên mắc của lao là: 20%
Một cộng đồng A có 100.000 dân. Năm 2000 có 1000 người chết do tất cả các nguyên nhân. Có 300 bệnh nhân lao, 200 nam và 100 nữ. Trong năm 2001 có 60 bệnh nhân lao chết, trong đó có 50 là nam. Tỷ lệ chết riêng phần theo nguyên nhân đối với lao là: 60/100.000
Một loại vacxin phòng bệnh cúm được thử nghiệm trên một nhóm người tình nguyện là các nữ y tá trẻ. Trong số 95 cá nhân được nhận tiêm vacxin, có 3 trường hợp bị ốm, và trong số 95 cá nhân đã nhận placebo, có 16 trường hợp mắc bệnh cúm trong thời gian theo dõi. Tính toán nguy cơ tương đối (RR) Nhiễm bệnh cúm trong số những người nhận vắc xin và so với người nhận placebo : 3/16
Một nghiên cứu thuần tập trong thời gian 12 năm nhằm đánh giá nguy cơ của hút thuốc lá đối với bệnh tim mạch, người ta thấy tỉ lệ xảy ra cơn đau thắt ngực ở những người nghiện thuốc lá cao gấp 1,6 lần so với những người không nghiện thuốc lá. Chỉ số dùng để đo lường tỉ lệ mắc bệnh xảy ra là: Tỉ suất mới mắc
Một nhà nghiên cứu quan tâm đến bệnh căn của vàng da sơ sinh. Để nghiên cứu vấn đề này, ông ta đã chọn 100 trẻ em đã được chẩn đoán vàng da và 100 trẻ em sinh ra trong cùng một thời gian, ở cùng một bệnh viện mà không bị vàng da. Sau đó, ông ta xem xét lại tất cả các hồ sơ sản khoa và lúc đẻ của các bà mẹ để xác định phơi nhiễm trước và trong lúc đẻ. Đây là ví dụ về: Nghiên cứu bệnh chứng
Một thay đổi trong tỉ suất hiện mắc là hậu quả thay đổi của: Tỉ suất mới mắc
Mục đích của kỹ thuật ghép cặp nhằm: Kiểm soát các biến số đã được biết có ảnh hưởng tới sự phân bố của bệnh mà ta nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng
Người ta đã tiến hành thử nghiệm vacxin như sau: 1000 trẻ em 2 tuổi đã được chọn ngẫu nhiên để nhận một loại vacxin phòng một bệnh nào đó và được theo dõi trong 10 năm, trong số những

trẻ em này , 80% trẻ đã không mắc bệnh . Trong những kết luận sau, kết luận nào đúng nhất có liên quan tới hiệu quả vaccin: Không thể kết luận vì không nghiên cứu theo dõi những trẻ không được tiêm vaccin
Nguy cơ mắc bệnh có thể được đo lường bằng: Tỷ suất mới mắc @
Nguyên tắc phân giải kết quả của trắc nghiệm thống kê: Không được áp dụng máy móc và cứng nhắc giá trị P
Nhiều là yếu tố: Có liên quan tới cả phơi nhiễm và bệnh Nhiều là những yếu tố có những đặc điểm sau, TRỪ: Độc lập với những yếu tố phơi nhiễm@@
Những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra những biện pháp can thiệp có hiệu quả là: Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm
Những hạn chế của kỹ thuật ghép cặp là: Rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiều
ở một cuộc điều tra cơ bản, 17 người trong số 1000 người đó có dấu hiệu của bệnh mạch vành tim. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là: Tỷ suất hiện mắc @
ở một nghiên cứu cơ bản, 131 người trong số 1000 người ở lứa tuổi 60 - 64 đã mắc bệnh mạch vành tim. Chỉ số dùng để đo lường bệnh xảy ra là: Tỷ suất hiện mắc xác định theo tuổi
ở một nghiên cứu cơ bản, 131 người trong số 1000 người ở lứa tuổi 60 - 64 đã mắc bệnh mạch vành tim. Chỉ số dùng để đo lường bệnh xảy ra là: Tỷ suất hiện mắc xác định theo tuổi
Ở một nghiên cứu cơ bản, 131 người trong số 1000 người ở lứa tuổi 60-64 đã mắc bệnh mạch vành tim. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là: Tỷ suất hiện mắc xác định theo tuổi Một thay đổi trong tỉ suất hiện mắc là hậu quả thay đổi của: Tỷ suất mới mắc
Tại một quần thể trong năm 2004 người ta đã thống kê được có 1886 trường hợp chết trong năm đó. Để tính được tỷ lệ tử vong thô, người ta cần phải thu thập thêm các thông tin: Tổng dân số trong quần thể đó tại thời điểm giữa năm 2004@
Trong một cộng đồng bao gồm 100.000 người, có 1000 trường hợp mắc 1 bệnh, trong đó 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong 1 năm. Tỷ lệ chết vì bệnh này là : 0,2% @
Trong một cộng đồng có 1.000.000 người, có 1000 trường hợp mắc một bệnh cấp tính, trong đó có 300 trường hợp chết vì bệnh này trong năm. Tỷ lệ chết/mắc bệnh này trong năm là: 30%
Trong một cộng đồng có 100.000 người, có 1000 trường hợp bệnh và 200 trường hợp chết vì bệnh đó trong năm. Tỷ lệ chết do bệnh này (tỷ lệ chết theo nguyên nhân) trong năm đó là: 200/100.000
Trong một nghiên cứu 500 bệnh nhân và 500 người đối chứng, người ta đã tìm ra một yếu tố bệnh căn nghi ngờ ở 400 bệnh nhân và 100 người đối chứng. Nguy cơ tuyệt đối tỷ suất mới mắc ở những người có yếu tố này là: 80%
Trong một nghiên cứu sàng lọc tiến hành trên 5000 phụ nữ, người ta đã tìm thấy 25 người mắc bệnh ung thư vú. Năm năm sau đó người ta đã phát hiện thêm 10 trường hợp bị bệnh. Tỷ suất mắc bệnh sau 5 năm nghiên cứu là: 10/(5000 – 25)
Trong một nghiên cứu theo dõi bệnh sốt rét tại huyện miền núi có sử dụng thuốc Artemisinin để điều trị cho bệnh nhân sốt rét. Qua theo dõi 1892 người thấy có 244 trường hợp mới mắc trong thời gian theo dõi 2 năm (1999-2001). Tính tỷ suất mới mắc tích lũy của sốt rét trong thời gian nghiên cứu: 0.13
Trong một nghiên cứu về bệnh tăng huyết áp người ta phát hiện được 45 người mắc bệnh tăng huyết áp trong số 1000 người ở nhóm tuổi 15-49 được lấy vào nghiên cứu. Chỉ số dùng để đo lường bệnh xảy ra là: Tỷ suất hiện mắc
Tỷ lệ chết của trẻ em dưới 1 tuổi được đo bằng số trẻ chết: Dưới 1 năm tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống
Tỷ lệ chết ở trẻ sơ sinh bằng số chết: Dưới 28 ngày tuổi, trên 10.000 cuộc đẻ@

Tỷ lệ chết/mắc của một bệnh là: Tỷ lệ chết theo nguyên nhân do bệnh đó					
Tỷ suất hiện mắc bệnh tại một thời điểm được định nghĩa là : Số ca hiện mắc tại một thời điểm chia cho số dân ở thời điểm đó					
Tỷ suất hiện mắc của bệnh đái đường cao hơn so với một năm trước khi bắt đầu tiến hành chương trình phát hiện và điều trị tích cực là do : Giảm tỷ lệ chết so với số mắc bệnh đái đường					
Tỷ suất mắc bệnh tại một thời điểm được định nghĩa là: Số ca hiện mắc trong một thời điểm chia cho số dân ở thời điểm đó					
Tỷ suất mới mắc bệnh được định nghĩa là: Số ca mới mắc của một bệnh trong một thời gian chia cho số dân có nguy cơ lúc bắt đầu nghiên cứu					
TỶ	XUẤT	CHẾT	TRẺ	EM	LÀ
A. SỐ CHẾT CỦA TRẺ EM < 1 TUỔI CHIA CHO SỐ SINH SỐNG TRONG CÙNG MỘT THỜI KỲ TRONG MỘT DÂN SỐ NHẤT ĐỊNH					
Ví dụ về tỷ suất hiện mắc là : Tổng số bệnh nhân bị xơ cứng lan toả trên 100.000 dân hàng năm					
Yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất với tính giá trị của các kết luận rút ra từ một thử nghiệm lâm sàng: Câu 77 đề 3 đợt 2					

Bài 3: Phương pháp nghiên cứu mô tả

<i>Đặc điểm dưới đây KHÔNG phải ưu tiên của nghiên cứu tương quan: Kiểm soát được ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễu</i>
Đặc trưng không được đề cập đến trong nghiên cứu dịch tễ học mô tả: Căn nguyên @
Hạn chế của kỹ thuật ghép cặp: Rất khó chọn ra được những cặp ghép chặt chẽ theo đúng và đủ tiêu chuẩn về từng biến số nhiễu @
Hạn chế kết hợp giả tạo bằng: Chọn ngẫu nhiên @
Mô tả 1 trường hợp bệnh hoặc 1 chùm bệnh có những ưu điểm sau trừ Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn @
<i>Mô tả một trường hợp bệnh hoặc một chùm bệnh có những ưu điểm sau, TRỪ: Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn</i>
<i>NC mô tả là nghiên cứu các vấn đề sau, TRỪ: Kiểm định một giả thiết nhân quả</i>
<i>Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm mục đích sau, TRỪ: Xác định yếu tố nguy cơ</i>
<i>Nghiên cứu dịch tễ học mô tả nhằm: Hình thành giả thiết</i>
<i>Nghiên cứu DTH mô tả gồm các loại nghiên cứu dưới đây, TRỪ: Nghiên cứu hiệu quả điều trị</i>
tả một trường hợp bệnh hoặc một chứng bệnh có những ưu điểm sau trừ: Xác định căn nguyên trong thời gian ngắn@
ý dưới đây không phải ưu điểm của nghiên cứu tương quan: Kiểm soát được ảnh hưởng của các yếu tố gây nhiễu@

Bài 3: Phương pháp nghiên cứu bệnh chứng

Giai đoạn IV trong thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm: Đánh giá chỉ phí hiệu quả của thuốc
<i>Kỹ thuật phép cặp trong nghiên cứu bệnh chứng để:</i> Kiểm soát các biến số đã được biết là có ảnh hưởng tới sự phân bố của bệnh mà ta nghiên cứu ở cả hai nhóm bệnh và nhóm chứng
<i>Loại nghiên cứu nào sau đây là nghiên cứu bệnh chứng:</i> So sánh mức độ phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ ở nhóm bệnh nhân và nhóm người khỏe mạnh
Một loại vacxin phòng bệnh cúm được thử nghiệm trên một nhóm người tình nguyện là cô nữ y tá trẻ. Trong số 95 cá nhân được nhận tiêm vacxin, cứ 3 trường hợp bị ốm, và trong số 95 cá nhân đó nhận placebo, cứ 16 trường hợp mắc bệnh cúm trong thời gian theo dõi. Tính toán nguy cơ tương đối (RR) Nhiễm bệnh cúm trong số những người nhận vắc xin và so với
<i>Một nghiên cứu bệnh chứng có đặc điểm sau, TRỪ:</i> Có thể ước lượng được tỉ suất mới mắc
Một nhà nghiên cứu quan tâm đến bệnh căn của vàng da sơ sinh. Để nghiên cứu vấn đề này, ông ta đã chọn 100 trẻ em đã được chẩn đoán vàng da và 100 trẻ em sinh ra trong cùng một thời gian, ở cùng một bệnh viện mà không bị vàng da. Sau đó, ông ta xem xét lại tất cả các hồ sơ sản khoa và lúc đẻ của các bà mẹ để xác định phơi nhiễm trước và trong lúc đẻ. Đây là ví dụ về:
Nghiên cứu bệnh chứng
Người ta tiến hành một nghiên cứu về mối liên quan giữa thói quen hút thuốc lá của mẹ khi mang thai và cân nặng thấp của trẻ sơ sinh. Người ta tiến hành phỏng vấn tiền sử hút thuốc lá của 340 bà mẹ đẻ con có cân nặng thấp phát hiện ra có 40 bà mẹ có tiền sử hút thuốc lá khi mang thai. Đồng thời người ta cũng tiến hành phỏng vấn 366 bà mẹ đẻ con có cân nặng bình thường và phát hiện có 16 bà mẹ có tiền sử hút thuốc lá khi mang thai. Đây là ví dụ về:
Nghiên cứu bệnh chứng
Nhận xét nào dưới đây không đúng với nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập: Nghiên cứu thuần tập tương lai thường dễ áp dụng để làm sáng tỏ các yếu tố liên quan với các bệnh hiếm gặp.
<i>Nhận xét nào dưới đây là ưu điểm của một nghiên cứu bệnh chứng:</i> Thường được sử dụng để nghiên cứu bệnh căn các bệnh hiếm gặp
<i>Nhận xét nào sau đây mô tả ưu điểm của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên cả đối chứng, mù:</i> Nó rẻ tiền tiết kiệm thời gian
<i>Nhóm chứng cần thiết trong nghiên cứu bệnh chứng bởi vì:</i> Cho phép sự đánh giá khác biệt về mức độ phơi nhiễm giữa nhóm bệnh và nhóm chứng
Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm Giống nhóm chủ cứu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu@
<i>nhược điểm cơ bản của các nghiên cứu bệnh chứng về vai trò của yếu tố căn nguyên nghi ngờ khi so sánh với nghiên cứu thuần tập tương lai là:</i> Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của yếu tố nguy cơ.
Tăng cường sự tuân thủ trong nghiên cứu can thiệp bằng cách: Lựa chọn quần thể nghiên cứu phải đáng tin cậy và quan tâm đến nghiên cứu (A), tuân Anh (B)?
Trong một nghiên cứu 500 BN và 500 người đối chứng, người ta đó tìm ra một yếu tố bệnh căn nghi ngờ ở 400 bệnh nhân và 100 người đối chứng. Nguy cơ tuyệt đối tỷ suất mới mắc ở những người cú yếu tố này là: 80% @

Trong một nghiên cứu sàng lọc tiến hành trên 5000 phụ nữ, người ta đã tìm thấy có 25 người mắc bệnh ung thư vú. Năm năm sau đó, người ta đã phát hiện thêm 10 trường hợp bị bệnh. Tỷ mới mắc ung thư vú sau 5 năm nghiên cứu là:
 $10/(5000-25)$ @

Trong một nghiên cứu theo dõi bệnh sốt rét tại huyện miền núi có sử dụng thuốc Artemisinin để điều trị cho bệnh nhân sốt rét. Qua theo dõi 1892 người thấy cứ 244 trường hợp mới mắc trong thời gian theo dõi 2 năm (1999-2001). Tính tỷ suất mới mắc tích lũy của sốt rét trong thời gian nghiên cứu: 0.13 @

Trong một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, để đo lường tần số các triệu chứng phụ do dùng một thuốc điều trị, nhóm chứng nào dưới đây là phù hợp nhất: Nhóm đối chứng nhận placebo

Trong một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, những điều kiện nào dưới đây là phù hợp với việc loại trừ đối tượng nghiên cứu ra khỏi nhóm nghiên cứu: Những người không tuân thủ chế độ nghiên cứu sau khi đã được chọn ngẫu nhiên vào nhóm nghiên cứu

Bài 4: Phương pháp nghiên cứu thuần tập

<i>Đặc điểm nào dưới đây không phải là nghiên cứu thuần tập: Câu 58 đề 3 đợt 2</i>
<i>Hạn chế kết hợp giá tạo bằng: Không chế sai số nhớ lại</i>
<i>Kết quả nghiên cứu thuần tập thường được trình bày trong bảng: Bảng tiếp liên (2x2)</i>
Một nghiên cứu thuần tập trong thời gian 12 năm nhằm đánh giá nguy cơ của hút thuốc lá đối với bệnh tim mạch người ta thấy tỉ lệ xảy ra cơn đau thắt ngực ở những người nghiện thuốc lá cao gấp 1,6 lần so với những người không nghiện thuốc lá . Chỉ số dùng để đo lường tỉ lệ mắc bệnh xảy ra là: Tỉ suất mắc bệnh được chuẩn hoá
Nhận xét nào dưới đây không đúng với nghiên cứu bệnh chứng và nghiên cứu thuần tập: Nghiên cứu thuần tập tương lai thường được áp dụng để làm sáng tỏ các yếu tố liên quan với các bệnh hiếm gặp.@
Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm Giống nhau chủ yếu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu @
Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm : Giống nhóm chủ cứu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu
<i>Nhóm chứng trong nghiên cứu thuần tập là nhóm: Giống nhóm chủ cứu về tất cả các đặc điểm trừ phơi nhiễm nghiên cứu</i>
<i>Nhóm so sánh tốt nhất trong nghiên cứu thuần tập là: Cả nhóm so sánh bên trong và bên ngoài</i>
Nhược điểm cơ bản của các nghiên cứu bệnh chứng về vai trò của yếu tố bệnh căn nghi ngờ khi so sánh với nghiên cứu thuần tập tương lai là: Có thể có sai số hệ thống trong việc xác định sự có mặt hay không có mặt của yếu tố nguy cơ
<i>Sai số hay gặp nhất trong nghiên cứu thuần tập là: Câu 57 đề 3 đợt 2</i>
<i>Trong một nghiên cứu nhằm xác định liệu việc cắt bỏ amidam có kết quả với sự phát triển sau này bệnh hodgkin, nguy cơ tương đối ước lượng sự phát triển bệnh hodgkin ở những người cắt amidam là 2,9 với $p < 0,05$. Từ kết quả này có thể kết luận là: Tỉ suất mới mắc của bệnh Hodgkin ở những người cắt amidan trước đây cao gấp 2,9 lần so với những người không cắt amidan</i>
<i>Trong nghiên cứu thuần tập người ta thường không tính chỉ số nào sau đây: Tỉ suất chênh (OR)</i>
<i>Ưu điểm của nghiên cứu thuần tập là: Ước lượng chính xác hơn về nguy cơ mắc bệnh</i>

Bài 5: Phương pháp nghiên cứu can thiệp

1. *Những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra những biện pháp can thiệp có hiệu quả là:*

A. Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm@

2. **Trong nghiên cứu can thiệp ko cần nhắc tới:**

Thời gian tham gia vào nghiên cứu của nhóm đối chứng @

3. *Những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra những biện pháp can thiệp có hiệu quả là:*

Nguy cơ quy thuộc @

4. **Mẫu số để đo lường tỷ xuất mật độ mới mắc một bệnh xảy ra là:**

Số năm người quan sát được @

6. **ĐỂ NGỘ ĐỘC AFLATOXIN CÓ THỂ GÂY UNG THƯ GAN NGƯỜI TA LẤY SỐ LIỆU TRONG CÙNG 1 NĂM CỦA 16 QUỐC GIA VỀ TỶ XUẤT MỚI MẮC UNG THƯ GAN VÀ NỒNG ĐỘ TRUNG BÌNH CỦA AFLATOXIN TRONG THỨC ĂN VÀ XEM CHÚNG CÓ TƯƠNG QUAN VỚI NHAU HAY KHÔNG, NGHIÊN CỨU NÀY GỌI LÀ**
C. NGHIÊN CỨU TƯƠNG QUAN

7. **CUNG CẤP NƯỚC SẠCH LÀM GIẢM TỈ LỆ MẮC TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM < 5 TUỔI, ĐỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI NÀY NGHIÊN CỨU NÀO SAU ĐÂY THÍCH HỢP**
C. NGHIÊN CỨU CAN THIỆP

Mù kếp là kỹ thuật: Cả điều tra viên, đối tượng nghiên cứu và người phân tích đều không biết chỉ định phân bổ vào các nhóm nghiên cứu

11. *Nghiên cứu “làm mù kếp” một loại vaccin là một nghiên cứu trong đó:*

Cả người nghiên cứu lẫn đối tượng nghiên cứu không ai biết ai sẽ nhận vaccin, ai sẽ nhận placebo@

12. *Trong một nghiên cứu đo lường tần số các triệu chứng phụ do dùng một thuốc điều trị:*

Nhóm đối chứng nhận placebo là cần thiết để giải thích cho kết quả

13. *Nhận xét nào sau đây mô tả ưu điểm chủ yếu của thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên:*

Nó kích ứng về đạo đức?

14. *Nghiên cứu can thiệp là một nghiên cứu có các đặc điểm sau, TRỪ: Tình trạng phơi nhiễm ở đối tượng nghiên cứu được làm nghiên cứu chủ động chọn theo mục đích*

25. *Nghiên cứu nào dưới đây không phải là nghiên cứu can thiệp: Nghiên cứu xác định nguy cơ*

26. *Nguyên tắc chỉ định chế độ nghiên cứu trong nghiên cứu can thiệp là: Phải được tiến hành ngẫu nhiên*

27. *Tích lũy đủ số người phát triển hậu quả bệnh trong nghiên cứu can thiệp bằng: Thực hiện chế độ “chạy thử” trước khi phân bổ ngẫu nhiên*

29. *Tỷ suất hiện mắc của bệnh đái đường cao hơn năm trước khi bắt đầu tiến hành phát hiện và điều trị tích cực là do: Giảm số chết do mắc bệnh đái đường*

30. *Những chỉ số dịch tễ học có ích lợi nhất trong việc xác định các yếu tố nguy cơ trên cơ sở đó đề ra các biện pháp can thiệp hiệu quả là: Tỷ suất mới mắc bệnh ở những người có phơi nhiễm*

Bài 6: Chẩn đoán cộng đồng. Điều tra ngang

4. Mục đích điều tra dịch tễ học tại khu dịch là: Chọn biện pháp thích hợp nhất để xử lý khu dịch@

5. Điều tra ngang khụng gắn liền với tỉ lệ nào sau đây:

Tỷ suất mới mắc@

6. Điều tra ngang được tiến hành với cỡ chọn mẫu sau trừ 1 cách:

Mẫu ghép cặp@

7. Điều tra ngang có những ưu điểm sau :

Có thể làm trong thời gian ngắn, thu được kết quả nhanh chóng@

8. Để đánh giá mức độ kết hợp giữa 1 phơi nhiễm và 1 bệnh những chỉ số dịch tễ học có lợi nhất là:

Nguy cơ tương đối của bệnh @

9. Điều tra ngang được tiến hành với cách chọn mẫu sau, trừ 1 cách

Mẫu ghép cặp @

10. Bệnh tai biến mạch máu não là bệnh có các biểu hiện sau

TTCN thần kinh khu trú đột ngột ko do chấn thương, kéo dài >24h, có thể để lại di chứng @

11. Thông tin về phơi nhiễm ít gặp sai số nhất từ nguồn

Điều tra môi trường nước, không khí trực tiếp @

12. Hiện nay bệnh ho gà có khuynh hướng gia tăng ở cả nước phát triển vì

Việc tiêm chủng bị lơ là @

13. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh sởi là

Tiêm vacxin sởi cho trẻ từ 9 – 11 tháng tuổi @

14. Nguồn truyền nhiễm chính của bệnh viêm não nhật bản là: Chim lợn @

15. Yếu tố quyết định đường giải phóng vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ cũ là

Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh @

16. Kết hợp giả tạo có thể do: 1 vài sự sai sót hệ thống@

17. Người mang mầm bệnh là nguồn lây truyền bệnh: Bạch hầu @

18. Các biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm là: Tất cả các biện pháp kể trên @

1. KHỎI CẢM THỤ LÀ

D. TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI TRONG CỘNG ĐỒNG CÓ KHẢ NĂNG NHIỄM TRÙNG VÀ MẮC BỆNH

2. NHỮNG YẾU TỐ SAU ĐÂY, YẾU TỐ NÀO KHÔNG PHẢI LÀ YẾU TỐ TRUNG GIAN TRUYỀN BỆNH ĐỐI VỚI CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP

D. THỰC PHẨM

3. TRONG THỬ NGHIỆM CHỨNG MINH HIỆU QUẢ CỦA AZT TRÊN BỆNH NHÂN AIDS, MỘT NHÓM BỆNH NHÂN DÙNG AZT, MỘT NHÓM BỆNH NHÂN DÙNG PLACEBO, NGHIÊN CỨU NÀY MÙ ĐÔI NẾU

A. 3 NHÓM: 2 NHÓM BỆNH NHÂN VÀ BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ KHÔNG BIẾT BỆNH NHÂN DÙNG LOẠI THUỐC GÌ

4. NHẬN XÉT NÀO SAU ĐÂY MÔ TẢ ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU CỦA THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN

A. NÓ LOẠI TRỪ ĐƯỢC SỰ TỰ LỰA CHỌN CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀO CÁC NHÓM ĐIỀU TRỊ KHÁC NHAU

5. MỘT BỆNH ĐƯỢC GÂY RA BAO GIỜ CŨNG DO

D. 1 MẠNG LƯỚI CÁC NGUYÊN NHÂN

33. HÌNH ẢNH "TẢNG BĂNG TRÔI" TRONG CỘNG ĐỒNG NÓI LÊN ĐIỀU GÌ

A. CHỈ 1 SỐ ÍT CÁ THỂ CỦA BỆNH ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG CỘNG ĐỒNG

34. CHẨN ĐOÁN CỘNG ĐỒNG LÀ

C. PHÁT HIỆN TRONG CỘNG ĐỒNG NHỮNG BỆNH TRẠNG CÒN Ở TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN LÂM SÀNG

35. ĐỂ CHẨN ĐOÁN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TA DÙNG NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NÀO

B. CÁC CUỘC ĐIỀU TRA VÀ KỸ THUẬT SÀNG TUYỂN

36. NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN LÀ

B. NHỮNG BỆNH NHIỄM TRÙNG MÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀO CƠ THỂ BỆNH NHÂN TRONG LÚC HỌ ĐANG NẪM VIỆN

37. TRƯỜNG HỢP NÀO SAU ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN

C. 1 BỆNH NHÂN VÀO NĂM VIỆN ĐÃ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NGOẠI CHẤN THƯƠNG VỚI LÝ DO GÂY XƯƠNG ĐÙI THÌ LÊN CƠN SỐT, XÉT NGHIỆM THẤY KST SỐT RÉT TRONG MÁU

38. TRONG NHÓM VI KHUẨN GRAM (-) LOẠI VI KHUẨN GÂY NHIỄM TRÙNG PHỔ BIẾN NHẤT LÀ

D. TƯƠNG ĐƯƠNG NHAU

39. TRONG NHÓM VI KHUẨN GRAM (-) LOẠI VI KHUẨN GÂY NHIỄM TRÙNG PHỔ BIẾN NHẤT LÀ

C. E.COLI

40. CON VI KHUẨN GÂY "NHIỄM TRÙNG CƠ HỘI" ĐIỂN HÌNH LÀ

D. TK MỦ XANH

41. HIỆN NAY VI KHUẨN ÍT KHÁNG THUỐC NHẤT LÀ

D. LIÊN CẦU NHÓM A

42. TỰ CẦU THƯỜNG GÂY BỘI NHIỄM NHIỀU NHẤT Ở KHOA

A. NHI VÀ NGOẠI

43. NHẬN XÉT NÀO SAU ĐÂY KHÔNG ĐÚNG, NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN LÀ

D. DO SỰ KHÁNG THUỐC CỦA VI KHUẨN

44. Ở VIỆT NAM BỆNH NÀO CÓ TỶ SUẤT TỬ VONG CAO NHẤT

D. LAO

45. TRONG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA TRỰC TIẾP TỶ SUẤT TỬ VONG

B. NGƯỜI TA ÁP ĐẶT CẤU TRÚC DÂN SỐ CỦA DÂN SỐ CHUẨN LÊN 2 NHÓM DÂN SỐ

46. PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA TRỰC TIẾP CÓ ƯU ĐIỂM HƠN PHƯƠNG PHÁP CHUẨN HÓA GIÁN TIẾP "NGOẠI TRỪ"

A. CÓ THỂ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TỶ SUẤT TỬ VONG CỦA TỪNG NHÓM TUỔI Ở DÂN SỐ MUỐN ĐƯỢC CHUẨN HÓA

47. TRONG NGHIÊN CỨU BỆNH CHỨNG NHẮM CHỨNG MINH ĂN NHIỀU CHẤT BÉO VÀ K VÚ TRÊN PHỤ NỮ TP.HCM (NHÓM CHỨNG LÀ MẪU ĐẠI DIỆN CHO PHỤ NỮ THÀNH PHỐ), NÊN TÌM NHỮNG TRƯỜNG HỢP K VÚ Ở

A. TẤT CẢ NHỮNG BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ K VÚ Ở TP.HCM NHƯNG LOẠI BỎ NHỮNG PHỤ NỮ TỪ CÁC TỈNH KHÁC TỚI

48. MỘT KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM VỚI GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH LÀ 18g/100ml, ĐỘ LỆCH CHUẨN LÀ 1.5/100ml, CÓ NGHĨA LÀ

C. NẾU TIẾN HÀNH XÉT NGHIỆM LẠI TRÊN CÙNG 1 MẪU, 95% CÁC GIÁ TRỊ SẼ NẪM TRONG KHOẢNG

49. NGHIÊN CỨU CẮT NGANG CÓ THỂ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU "NGOẠI TRỪ"

D. TÌM TỶ SUẤT CHẾT/MẮC CỦA BỆNH THƯỜNG HÀN

50. TRONG 1 NGHIÊN CỨU ĐOÀN HỆ TÍNH ĐƯỢC $RR = 2.3$ ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ

A. 1 NGƯỜI TIẾP XÚC CÓ NGUY CƠ MẮC BỆNH NHIỀU HƠN NGƯỜI KHÔNG TIẾP XÚC 2.3 LẦN

ĐÁP ÁN: A:37000000:

Điều tra ngang không gắn liền với tỉ lệ nào sau đây:

Tỷ suất mới mắc@

Điều tra ngang được tiến hành với cách chọn mẫu sau trừ 1 cách:

Mẫu ghép cặp@

Điều tra ngang có những ưu điểm sau :

Có thể làm trong thời gian ngắn, thu được kết quả nhanh chóng@

19.Các bệnh truyền nhiễm được phân loại dựa vào:

Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

20.*Dịch được định nghĩa là:* Sự xuất hiện của bệnh vượt quá số mong đợi trung bình ở quần thể đó trong thời gian đó

21.*Nguồn truyền nhiễm chính của viêm não Nhật Bản là:* Chim, lợn

Bài 7: Đo lường kết quả và suy luận nhân quả trong nghiên cứu DTH

22. So sánh tỷ lệ tử vong do K tử cung ở những người có và không dùng nội tiết tố Oestrogen cho thấy

Tỷ lệ tử vong / 100.000 người

	Tuổi 40 – 50	Tuổi 55 – 70
Dùng oestrogen	3,0	17,0
Không dùng	1,0	6,0

Kết luận có giả thiết thu được từ số liệu trên có liên quan với tỷ lệ tử vong ở những người dùng oestrogen là

A. Có thể có mối quan hệ giữa sử dụng oestrogen và tỷ suất mới mắc của K tử cung @

23. Là 1 yếu tố có liên quan về nguyên nhân gây bệnh, 1 yếu tố bệnh cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

Phơi nhiễm với yếu tố đó phải xảy ra trước khi phát triển bệnh @

24.Chọn tình huống đúng

Người ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự kết hợp giữa hút thuốc lá và K phổi. Những kết luận nào sau đây đúng với sự kết hợp giữa hút thuốc lá và K phổi và đưa ra bằng chứng về mối quan hệ nhân quả:

Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy tỷ lệ có vết loét tiền K tăng lên sau khi hít khói thuốc lá vào phổi @

Bài 9: Sàng tuyển phát hiện bệnh sớm

25.Mục đích điều tra dịch tễ học tại khu dịch

Tính tỷ suất hiện mắc @

26.Cách ly có nghĩa là sự tách biệt hoạt động của

Tất cả những người đã tiếp xúc @

27.Phát hiện sớm 1 bệnh nhân trong 1 vụ dịch ko dựa vào

Các nghiên cứu dịch tễ học phân tích @

28.Người Mang mầm bệnh là nguồn lây truyền bệnh

Bạch hầu @

29.Giai đoạn 1 trong thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm:

Thực nghiệm ở những người tình nguyện khỏe mạnh @

30.Mức độ kết hợp giữa yếu tố nguy cơ và bệnh được đo lường tốt nhất bằng

Nguy cơ tương đối @

31.Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh

Dại @

32.Chim là ổ chứa thiên nhiên

Viêm não Nhật Bản @

Bài 10: Quá trình dịch và phân loại các bệnh nhiễm

33. **Nguồn lây nhiễm chính của viêm não Nhật Bản:** Chim, lợn @
34. **Dịch được định nghĩa là:** Sự xuất hiện của bệnh vượt quá số mong đợi @
35. **Bệnh lây truyền theo phương thức trực tiếp:** Đại @
36. **Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh:** Đại @
37. **Ghép cặp là kỹ thuật:** Ghép cặp làm triệt tiêu yếu tố nhiễu @
38. **Ghép cặp là phép dùng để:** Kiểm soát các biến số đã được biết có ảnh hưởng.. @
39. **Khoảng tin cậy:** Cỡ mẫu càng lớn khoảng tin cậy càng hẹp @
40. **Giả thiết P trong trắc nghiệm thống kê :** Càng nhỏ thì giả thiết của ý nghĩa thống kê càng lớn @
41. **Đánh giá vai trò của may rủi bằng:** Kiểm định giả thuyết @
42. *Người lành mang mầm bệnh là nguồn lây nhiễm mang mầm bệnh: Thương hàn*

Bài 11: Nguyên lý phòng chống dịch. Tiêm chủng mở rộng.

Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh nhân sởi là: Tiêm vaccin cho trẻ từ 9-11 tháng tuổi

Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với bệnh viêm não Nhật Bản là: Tiêm vaccin VNNB cho lứa tuổi cảm nhiễm ở vùng có lưu hành bệnh

Vaccin tiêm cho phụ nữ có thai và phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là: Vaccin uốn ván

Yếu tố quyết định sự đào thải vi sinh vật gây bệnh ra khỏi vật chủ là: Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

Nguồn truyền nhiễm chính của viêm não nhật bản là: Chim, lợn

Chẩn đoán phát hiện sớm một bệnh nhân trong một vụ dịch cần phải dựa vào: Các phương pháp trên

Các biện pháp chủ yếu để phòng chống truyền nhiễm là: Tất cả các biện pháp trên:

Các loài chim là ổ chứa trong thiên nhiên của bệnh: Viêm gan B

Bệnh có khả năng lây truyền từ cuối thời kỳ ủ bệnh là: Bệnh sởi

Bệnh lây truyền theo phương thức trực tiếp là: Bệnh dại

Các bệnh truyền nhiễm được phân loại dựa vào: Vị trí cảm nhiễm thứ nhất của vi sinh vật gây bệnh

Yếu tố thiên nhiên ảnh hưởng tới sự phát sinh và phát triển của quá trình dịch chủ yếu là qua: Yếu tố truyền nhiễm

Dịch được định nghĩa là: Sự xuất hiện của bệnh đó vượt quá số mong đợi trung bình của quần thể đó trong thời gian đó

Nguồn truyền nhiễm của bệnh sởi là: Người khỏi mang vi rút bệnh

Nguồn truyền nhiễm của bệnh than từ: Thực phẩm bị nhiễm vi trùng than@@@

43. Biện pháp hiệu quả nhất trong điều trị dự phòng Viêm gan B là: Tiêm vaccin viêm gan B

44. Vaccin tiêm cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ

A. Uốn ván @

45. Vaccin tiêm 3 lần lúc trẻ 2, 3, 4, tháng tuổi là:

A. BH – HG – UV @

46. Các vaccin trong chương trình tiêm chủng mở rộng

Bại liệt @

47. Tất cả các đặc tính sau về bệnh BH – HG – HV là đúng, trừ 1 đặc trưng

Vaccin ho gà là giải độc tố, thường gây những phản ứng phụ @

48. Tiêm chủng ho gà chống chỉ định ở người

Trên 13 tuổi @

49. Bệnh có vaccin điều trị dự phòng

Dại @

50. Những người mang mầm bệnh thương hàn mãn tính phải

Đăng ký và theo dõi ở trung tâm y tế dự phòng nơi họ ở @

51. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất với bệnh bại liệt là:

Uống vacxin sabin @

52. Nghiên cứu trường hợp

Một mẹ mang cháu gái 11 tháng bị ỉa chảy tới trạm y tế. người mẹ đang cho con bú. Bà nói rằng nhà bà ở xa trạm y tế nên ko thể trở lại trạm y tế trong vài này, ngay cả khi tình trạng cháu xấu đi. Người mẹ nói rằng bà cho cháu bé uống nước chè loãng khi cháu bị ỉa chảy, nhưng nghe nói ở trạm y tế có loại dịch tốt hơn nên bà đưa cháu tới trạm. Cán bộ y tế khám cháu bé nhưng không tìm thấy dấu hiệu mất nước. Cán bộ y tế hướng dẫn bà mẹ

Khuyến người mẹ cho con ăn bột có thêm dầu thực vật, rau nấu kỹ và cho thêm 1 ít thịt nghiền. ngoài bú sữa mẹ, cần tiếp tục cho ăn ít nhất 6 lần một ngày @

53. Trong 1 nghiên cứu theo dõi bệnh sốt rét tại huyện miền núi có sử dụng thuốc

Artermisi. Để điều trị cho BN sốt rét qua theo dõi 1892h thấy có 244 TH mới mắc.

Trong thời gian theo dõi 2 năm (1999-2001) . Tính tỷ suất mới mắc tích lũy của sốt rét trong thời gian nghiên cứu

A. 0,13 @

34. Giai đoạn II trong thử nghiệm thuốc điều trị không bao gồm

C. Thử nghiệm mang tính thử nghiệm lâm sàng @

40. Người ta đã tiến hành thử nghiệm vacxin như sau : 1000 trẻ em 2 tuổi đã được chọn ngẫu nhiên để nhận một loại vacxin phòng bệnh nào đó và được theo dõi trong 10 năm, trong số những trẻ này, 80% trẻ đã không mắc bệnh . Trong những kết luận sau, kết luận nào là đúng nhất có liên quan tới hiệu quả của vacxin

B. Không thể kết luận được vì không nghiên cứu theo dõi những trẻ không được tiêm vacxin @

50. Biện pháp nào sai đây không phải là biện pháp khống chế nhiều

Ghép cặp @

60. Bệnh lây truyền qua đường máu **không** có ổ dịch thiên nhiên: Bệnh viêm gan B,C

Bệnh chỉ lây truyền từ người sang người: Bệnh giang mai

Bệnh chỉ lây truyền từ động vật sang người: Bệnh dại

Những người chưa tiêm huyết thanh giải độc tố uốn ván thì phải tạo miễn dịch bị động khi bị:

Tất cả các trường hợp trên

Bài 12: DTH nhóm bệnh truyền nhiễm đường hô hấp

Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường hô hấp là: Tất cả các loại kể trên

54. Con ho điển hình của bệnh ho gà gồm

Ho nhiều cơn, giữa các cơn ho nghe có tiếng ót @

55. Cúm là 1 trong những bệnh gây nên đại dịch lớn vì

A. Sự thay đổi kháng nguyên của virus @

56. phù hợp với bệnh cúm

Người bệnh và người lành mang trùng là nguồn bệnh duy nhất @

57. Sốt bại liệt, thể lâm sàng thường gặp

A. Liệt mềm @

58. Biện pháp xử trí nào kể sau ích lợi nhất cho 1 BN bị cúm

A. Truyền dịch để cân bằng nước điện giải, thăng bằng kiềm toan tích nước @

59. ĐỐI VỚI CÁC BỆNH LÂY QUA ĐƯỜNG HÔ HẤP MUỐN PHÒNG DỊCH TỐT QUAN TRỌNG NHẤT LÀ

C. GÂY MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU VÀ KHÔNG ĐẶC HIỆU

60. Chọn tình huống đúng:

Người ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự kết hợp giữa hút thuốc lá và ung thư phổi.

Những kết luận nào sau đây khẳng định sự kết hợp giữa hút thuốc lá và ung thư phổi và đưa ra được bằng chứng về mối quan hệ nhân quả?

Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cho thấy tỷ lệ có vết loét tiền ung thư tăng lên sau khi hít khói thuốc lá vào phổi @

Bài 13: DTH nhóm bệnh truyền nhiễm da và niêm mạc

Động vật ngặm nhấm và chuột là nguồn truyền nhiễm của bệnh: Dịch hạch

Bệnh lây truyền theo đường da và niêm mạc: Bệnh dại

Nhìn chung, biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với hầu hết các bệnh truyền nhiễm qua đường da và niêm mạc là: Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân

61. Phương pháp phòng chống có hiệu quả nhất với bệnh sởi: Tiêm vacxin cho trẻ từ 9-11 tháng tuổi @

62. Gamma globulin phòng bệnh có hiệu quả cho những người đã tiếp xúc với BN trong những bệnh sau

A. Sởi @

63. Nhìn chung các biện pháp phòng chống hiệu quả nhất đối với bệnh truyền nhiễm qua da và niêm mạc là

Giáo dục sức khỏe và vệ sinh cá nhân @

64. Bệnh giun chỉ chủ yếu lây qua đường

Muỗi đốt @

65. Đường lây truyền chính của bệnh giang mai

Niêm mạc @

66. Đường lây truyền phổ biến nhất của bệnh dịch hạch là: Đường da và niêm mạc

Bài 14: DTH nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa

Biện pháp phòng chống có hiệu quả nhất đối với các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa là: Cách ly và thải trừ chất thải bỏ của bệnh nhân@

Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa là: Tất cả các loại kể trên

67.Những người mang mầm bệnh thường hàn mãn tính phải

Đăng ký và theo dõi ở trung tâm y tế dự phòng nơi họ ở @

68.Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa là: Tất cả các ý trên

69.Nguồn truyền nhiễm chính của bệnh thương hàn: Người khỏi mang VK thương hàn

70.Những bệnh lây truyền chủ yếu qua phân bao gồm: Thương hàn @

71.Tỷ lệ chết / mắc bệnh TẢ hiện nay < 1%. Yếu tố chủ yếu làm cho tỷ lệ này thấp là: Khử trùng nguồn nước bằng cloramin trong vùng dịch @

72.Các biện pháp chủ yếu để phòng chống các bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa là
Tất cả các ý trên @

73.Rotavirus là nguyên nhân của 50% các trường hợp tiêu chảy ở trẻ em ở: 6 – 24 tháng tuổi

74.Nguồn truyền nhiễm của nhóm bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa là: Tất cả các loại kể trên @

11. CÓ MỘT VỤ DỊCH TIÊU CHẢY NHỎ XẢY RA TẠI MỘT TRƯỜNG MẪU GIÁO, CÁC CÁN BỘ Y TẾ ĐÃ XÉT NGHIỆM CHO CÁC CHÁU THẤY TÁC NHÂN GÂY BỆNH LÀ SAMONELLA, TRONG NHỮNG GIẢ THUYẾT SAU ĐÂY GIẢ THUYẾT NÀO ĐƯỢC LOẠI BỎ ĐẦU TIÊN

C. MỘT TRONG SỐ CÁC CHÁU BỊ NHIỄM SAMONELLA

12. TRONG CUỘC NGHIÊN CỨU NGANG VỀ LOÉT DẠ DÀY TRONG 1 CỘNG ĐỒNG, TỈ LỆ NHỮNG NGƯỜI CÓ ĐỦ TRIỆU CHỨNG ĐỂ CHẨN ĐOÁN LOÉT DẠ DÀY LÀ 80/100000 ĐÀN ÔNG Ở LỨA TUỔI 35 – 49 VÀ 90/100000 PHỤ NỮ Ở LỨA TUỔI 35 – 49, NGƯỜI TA CÓ THỂ KẾT LUẬN RẰNG Ở NHÓM TUỔI NÀY PHỤ NỮ CÓ NGUY CƠ CAO BỊ LOÉT DẠ DÀY. KẾT LUẬN NÀY LÀ

D. KHÔNG ĐÚNG VÌ KHÔNG CÓ NHÓM SO SÁNH HAY ĐỐI CHỨNG

13. Động vật là nguồn truyền nhiễm của bệnh: Bệnh dại @

14. Các loài chim là ổ chứa trong thiên nhiên của bệnh: Viêm não Nhật Bản@

Bài 15: DTH nhóm bệnh truyền nhiễm đường máu

- 75.Số trường hợp mới mắc sốt bại liệt hàng năm ở Việt Nam từ 1992 – 1996 có khuynh hướng: Giảm @
- 76.Bệnh sốt xuất huyết Dengue thường gặp ở: Các nước khí hậu nhiệt, cận nhiệt @
- 77.Tác nhân gây bệnh có thể lây theo đường tình dục là: *Treponema palliclum* @
- 78.Tỷ lệ mắc sốt xuất huyết Dengue cao nhất Việt Nam trong những năm gần đây gặp ở các khu vực: Miền Trung – Tây Nguyên @
- 79.Bệnh sốt xuất huyết Dengue lây qua đường: Truyền máu @
- 80.Bệnh sốt xuất huyết Dengue thường gặp ở: Các nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới @
- 81.Tác nhân gây bệnh xuất huyết Dengue bởi nhóm virus sau: *Plavivididae* @
- 82.Các bệnh lây truyền qua đường máu không có ổ dịch...: Bệnh viêm gan B, C @
- 83.Loại plasmodium nào dưới đây là nguyên nhân chính gây bệnh sốt rét: *P. falciparum* @
- 84.Những chỉ số nào dưới đây dùng để phân loại mô hình dịch tễ sốt rét: Cả 3 chỉ số trên @
- 85.Đường lây truyền phổ biến nhất của dịch hạch: Đường máu @
128. ĐỐI VỚI TRUYỀN NHIỄM LÂY QUA ĐƯỜNG MÁU MUỐN PHÒNG DỊCH TỐT QUAN TRỌNG NHẤT LÀ
- A. DIỆT VECTƠ TRUYỀN BỆNH VÀ AN TOÀN TRUYỀN MÁU VÀ TIÊM CHÍCH

Bài 16: DTH của HIV/AIDS

Phương pháp có hiệu quả nhất cho phòng chống HIV/AIDS là: Giáo dục thay đổi hành vi và xây dựng hành vi an toàn

Phương thức lây truyền HIV chủ yếu ở Việt Nam hiện nay là: Tiêm chích ma túy

86. Các dịch trong cơ thể là nguyên nhân lan truyền HIV. Dịch trong cơ thể chứa virus và điều này có nghĩa là người ta sẽ phải cẩn thận. Tất nhiên, ngoài tinh dịch và máu đã được biết là có chứa virus, các dịch khác cũng có thể chứa HIV. Tránh xa nước tiểu của người khác. Đừng hôn quá sâu những người có xét nghiệm HIV dương tính. Sữa mẹ có thể chứa HIV. Thậm chí mồ hôi có thể gây nguy hiểm. Điều đó giải thích tại sao mà những vận động viên bóng rổ Mỹ từ chối chơi với những người đồng nghiệp có xét nghiệm HIV dương tính“

A. Điều này ko đúng vì mồ hôi chỉ gây ra vấn đề nếu có tiếp xúc với vết thương hở @
87. HIV/AIDS là vấn đề của những nhóm có nguy cơ cao nhất định. Nếu chúng ta có thể tác động tới những nhóm này để thay đổi hành vi của họ, chúng ta sẽ có thể giải quyết tư vấn HIV/AIDS cho những nhóm quần thể khác

Điều này ko đúng vì thuật ngữ “nhóm có nguy cơ cao” không còn được dùng trong HIV/AIDS. Nó làm những người không thuộc nhóm này hiểu nhầm về sự an toàn của mình và làm tăng sự e ngại ko cần thiết đối với những nhóm nhất định của xã hội @

1. “bất kể tiếp xúc với máu của người khác đều có thể là nguy hiểm. Quá nhiều người hiện đang nhiễm HIV. Những người bị HIV không nên dùng bàn chải đánh răng chung với những người khác. Lý do nhiều người ở Châu Phi nhiễm HIV là do muỗi sốt rét, muỗi này đốt người nhiễm virus sau đó một thời gian lại đốt người khác và bên cạnh việc truyền sốt rét nó còn truyền HIV “

A. Điều này không đúng vì người ta chưa biết đến một trường hợp truyền HIV nào thông qua việc dùng chung bàn chải đánh răng hoặc do muỗi đốt @

2. Có ý kiến cho rằng “ Chính phủ phải hành động khẩn cấp. Cho đến nay chưa có nhiều người bị nhiễm HIV, chính phủ nên cách ly những người bị HIV để bảo vệ cho những người khác “

Điều này không đúng vì Cách tốt nhất để bảo vệ mọi người là giáo dục họ đường lây truyền để họ có thể bảo vệ cho bản thân họ @

3. Cách phòng lây truyền HIV hiệu quả nhất là sử dụng bao cao su. Nếu tất cả mọi người đều sử dụng bao cao su thì chỉ có một số ít người không sử dụng bao cao su là bị nhiễm HIV. Lây truyền qua đường tình dục là quan trọng nhất mặc dù các đường lây truyền khác cũng quan trọng nhưng có số người nhiễm ít hơn:

Điều này là không đúng vì những yếu tố khác như tiêm chích ma túy, truyền máu, không tiệt trùng cẩn thận bơm kim tiêm trong chăm sóc y tế là quan trọng hơn @

4. Ở một số nước người ta đã áp dụng chương trình trao đổi bơm kim tiêm cho những người nghiện chích ma túy tĩnh mạch. Các chương trình này thất bại vì tiêm chích ma túy là mối quan tâm của ngành công an chứ không phải của ngành y tế công cộng

Điều này là không đúng bởi vì tỷ lệ nhiễm HIV ở những người tiêm chích ma túy ở những nước đã áp dụng chương trình trao đổi bơm kim tiêm cho những người nghiện chích ma túy tĩnh mạch thấp hơn so với những nước không áp dụng chương trình này @

5. Phương thức lây truyền HIV chủ yếu hiện nay ở Việt Nam là

Tiêm chích ma túy @

6. TRONG THỬ NGHIỆM CHỨNG MINH HIỆU QUẢ CỦA AZT TRÊN BỆNH NHÂN AIDS, 1 NHÓM BỆNH NHÂN ĐƯỢC DÙNG PLACEBO, NHÓM NÀY GỌI LÀ D. NHÓM ĐỐI CHỨNG

88. Phương pháp có hiệu quả nhất phòng chống HIV/AIDS là : Giáo dục thay đổi hành vi và xây dựng hành vi an toàn

Bài 17: DTH một số bệnh không lây phổ biến (tim mạch và ung thư)

Các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp nguyên phát là: Tất cả các loại kể trên

Các yếu tố nguy cơ của bệnh mạch vành là: Tất cả các loại kể trên

89.ở 1 cuộc điều tra cơ bản 17 người trong số 1000 người đã có dấu hiệu của bệnh mạch vành tim. Chỉ số đo lường bệnh xảy ra là

A. Tỷ suất hiện mắc @

90.Các yếu tố làm tăng nguy cơ K đại tràng

A. Thức ăn giàu mỡ và đạm động vật @

91.Các yếu tố làm tăng nguy cơ K vú

A. Thức ăn giàu mỡ @

92.Biện pháp hiệu quả phòng chống K gan nguyên phát

Tiêm vacxin viêm gan B cho trẻ em @

93.Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

Virut gây u nhú ở người @

94.Bệnh tim mạch là mô hình bệnh tật của

A. Các nước phát triển giàu có @

95.Các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp tiên phát

Tất cả @

96.Các biện pháp phòng chống bệnh tăng HA là

Tất cả @

97.Virut gây u nhú là yếu tố nguy cơ gây K

A. Cổ tử cung @

98.Tiêu chuẩn của 1 căn nguyên đối với bệnh ko nhiễm trùng trừ:

Bệnh đa yếu tố@

99.Bảng sau trình bày kết quả của 1 nghiên cứu về yếu tố ... tương ứng với chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung

Tầng lớp xã hội			Tỷ lệ % đáp ứng	
Cao			75	
Thấp			46	
Cả cao và thấp			53	
Tình trạng hôn nhân				
Có gia đình			82	
Sống độc thân			68	
Góa hay ly dị			43	
Tất cả các tình trạng hôn nhân			53	
Tầng lớp xã hội	Có gia đình	Sống độc thân	Góa/ly dị	chung
Cao	83	67	43	75
Thấp	81	89	43	46
chung	82	88	43	53

Từ các số liệu trên, suy luận nào sau đây là đúng:

Không thể rút ra kết luận gì từ những số liệu này và không ...hôn nhân của những người ở tầng lớp xã hội cao và thấp @

**100. Mỗi liên quan giữa béo phì và tăng huyết áp
(số liệu được trình bày trong bảng số liệu nguồn)**

	HA thấp	HA trung bình	HA cao	Tổng
Béo phì	50	50	100	200
Bình thường	170	30	100	400
Gây	380	20	199	599
Tổng	600	100	399	1099

A. $50/100 = 50\%$ số người có huyết áp trung bình là béo phì @

101. Chọn tình huống đúng

Người ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự kết hợp giữa hút thuốc là và K phổi. Những kết luận nào sau đây khẳng định sự kết hợp giữa hút thuốc là và K phổi và đưa ra được bằng chứng về mối quan hệ nhân quả

Các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật cần thấy tỷ lệ có vết loét trên họng tăng lên sau khi hít thuốc lá vào phổi @

102. NGUY CƠ MẮC BỆNH MẠCH VÀNH TIM TRONG 1 NĂM TRONG NHỮNG NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ Ở DÂN SỐ A LÀ 669/100000, NGUY CƠ Ở NHÓM NGƯỜI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ LÀ 413/100000, NGUY CƠ TƯƠNG ĐỐI Ở NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ LÀ

A. 1.62

103. CÓ 1 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ TỈ LỆ K CỔ TỬ CUNG CỦA PHỤ NỮ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG TEST PAPANICOLAOU VÀ TÌM NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA TÌNH TRẠNG NÀY (TÁC GIẢ ĐỀ TÀI ĐÃ LÀM GÌ)

A. CÔNG TÁC DỰ PHÒNG CẤP 2

104. TRONG NGHIÊN CỨU SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA HÚT THUỐC LÀ NHỒI MÁU CƠ TIM, YẾU TỐ GÂY NHIỀU LÀ

A. CAO HUYẾT ÁP

105. NGUY CƠ MẮC BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM Ở NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ LÀ 0.1 VÀ NGUY CƠ Ở NGƯỜI KHÔNG HÚT THUỐC LÁ LÀ 0.02, NẾU NGƯỜI HÚT THUỐC LÁ BỎ HÚT THÌ NGUY CƠ CỦA HỌ SẼ GIẢM BỐT

B. 0.08

106. MỘT NGHIỆM PHÁP SÀNG TUYỂN PHÁT HIỆN UNG THƯ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN 400 PHỤ NỮ K VÚ (ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG GIẢI PHẪU BỆNH) VÀ 400 PHỤ NỮ KHÔNG BỊ K VÚ. KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH CỦA NGHIỆM PHÁP NÀY ĐƯỢC THẤY Ở 100 BỆNH NHÂN BỊ UNG THƯ VÀ 50 PHỤ NỮ BÌNH THƯỜNG. ĐỘ ĐẶC HIỆU CỦA NGHIỆM PHÁP LÀ

C. 87%

107. MỘT NGHIỆM PHÁP SÀNG TUYỂN PHÁT HIỆN UNG THƯ ĐƯỢC TIẾN HÀNH TRÊN 400 PHỤ NỮ K VÚ (ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BẰNG GIẢI PHẪU BỆNH) VÀ 400 PHỤ NỮ KHÔNG BỊ K VÚ. KẾT QUẢ DƯƠNG TÍNH CỦA NGHIỆM PHÁP NÀY ĐƯỢC THẤY Ở 100 BỆNH NHÂN BỊ UNG THƯ VÀ 50 PHỤ NỮ BÌNH THƯỜNG. GIÁ TRỊ DỰ ĐOÁN DƯƠNG TÍNH CỦA NGHIỆM PHÁP LÀ

A. 67%

108. Bảng sau trình bày kết quả của một nghiên cứu về các yếu tố có liên quan đến đáp ứng đối với chương trình sàng lọc ung thư cổ tử cung.

Tầng lớp xã hội		Tỷ lệ % đáp ứng		
Cao		75		
Thấp		46		
Cả cao và thấp		53		
Tình trạng hôn nhân				
Có gia đình		82		
Sống độc thân		68		
Góa hay li dị		43		
Tất cả các tình trạng hôn nhân		53		
Tất cả các tình trạng hôn nhân		53		
Tầng lớp xã hội	Có gia đình	Độc thân	Góa / li dị	Chung
Cao	83	67	43	75
Thấp	81	69	43	46
Chung	82	68	43	53

Từ các số liệu trên, suy luận nào sau đây là đúng:

Những phụ nữ có gia đình có tỷ lệ đáp ứng cao hơn những người sống độc thân hay góa bởi vì nhiều người trong số họ không thuộc tầng lớp xã hội cao

109. So sánh tỷ lệ tử vong do ung thư tử cung ở những người có và không dùng nội tiết Oestrogen cho thấy rằng:

	Tỷ lệ tử vong/ 100.000	
	Tuổi 40 - 50	Tuổi 55 - 70
Dùng Oestrogen	3,0	17,0
Không dùng Oestrogen	1,0	6,0

Kết luận có giá trị thu được từ số liệu trên có liên quan với tỷ lệ tử vong ở những người dùng Oestrogen là:

Tỷ lệ tử vong ở những người không dùng Oestrogen thấp hơn so với người dùng Oestrogen bởi vì những triệu chứng ung thư tử cung đã được phát hiện sớm hơn ở người không dùng Oestrogen

17. Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng là: Thức ăn giàu mỡ và đạm động vật

18. Biện pháp có hiệu quả phòng bệnh ung thư gan nguyên phát là: Tiêm vaccin viêm gan B cho trẻ em

19. Biện pháp phát hiện sớm ung thư cổ tử cung: Xét nghiệm tế bào cổ tử cung

20. Bệnh tim mạch là mô hình bệnh tật của: Các nước có nền công nghiệp phát triển ở Châu á
Nhật Bản, Đài Loan có các tỷ lệ gần tương đương với các nước phát triển Châu Âu, Châu Mỹ và tỷ lệ tử vong đã và đang giảm.

21. Bệnh tai biến mạch máu não là bệnh có các biểu hiện sau: Tổn thương chức năng thần kinh khu trú đột ngột không do chấn thương dài hơn 24h.có thể để lại di chứng

22. Vi rút gây u nhú là yếu tố nguy cơ gây ung thư: Cổ tử cung

BÀI: SAI SỐ TRONG DỊCH TỄ HỌC

Khống chế sai số trong nghiên cứu can thiệp bằng: Kỹ thuật làm mù

Thông tin về phơi nhiễm ít gặp sai số nhất từ những nguồn nào sau đây, TRỪ: Điều tra môi trường nước và không khí trực tiếp

Sai số thường gặp nhất liên quan đến thông tin về bệnh là từ nguồn nào sau đây, TRỪ: Hỏi trực tiếp đối tượng nghiên cứu hoặc người thân bằng các bộ câu hỏi@@@

Sai số hệ thống ít xảy ra trong nghiên cứu can thiệp: Khi loại bỏ những trường hợp không tuân thủ nghiên cứu ra ngoài kết quả

Kết hợp giả tạo có thể do các yếu tố nào sau đây: Sai số hệ thống

Hạn chế kết hợp giả tạo bằng các phương pháp sau đây, TRỪ: Chọn ngẫu cứu nhiên